

PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO

DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE SALUD
MENTAL Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS



Ministerio de Salud
Argentina

*primero
la gente*

PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO

**DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE SALUD
MENTAL Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS**

1. Introducción.

Responsables.

2. Marco Normativo.

3. Análisis Situacional.

4. Ejes y objetivos de trabajo.

Eje 1: Rectoría.

Eje 2: Prevención y Promoción.

Eje 3: Atención y Postvención.

Eje 4: Fortalecimiento del RRHH en Salud/Salud Mental.

Eje 5: Sistemas de Información y Vigilancia Epidemiológica.

5. Abordaje de la Problemática por Curso de Vida.

Infancia y adolescencia.

Personas mayores.

6. Evaluación y Monitoreo.

7. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN.

El tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio, publicado en marzo de 2021 por la Organización Mundial de la Salud, indica que esta problemática sigue siendo una prioridad de salud pública a nivel mundial. Asimismo, los datos de los que se dispone actualmente confirman que el suicidio es prevenible y que se precisa de un enfoque intersectorial para que las estrategias sean eficaces.

Abordar la problemática del suicidio implica pensar en términos de complejidad y multicausalidad. Se trata de un fenómeno de gran magnitud tanto a nivel mundial como en nuestro país, que afecta al tejido social, con alto impacto subjetivo para el entorno familiar y social de la persona y su comunidad de pertenencia, con efectos de amplio alcance.

Para abordar esta problemática y contribuir a disminuirla, la estrategia principal es la prevención, entendida desde una perspectiva de cuidados integrales y colectivos, en especial en los grupos etarios de adolescentes y de personas mayores.

Las acciones, en concordancia con la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio, deben tender a garantizar el abordaje temprano e integral del riesgo de suicidio, el fortalecimiento de la red de atención y la calidad de los registros sobre los suicidios consumados y los intentos de suicidio. El desarrollo de estas acciones es importante que se den en el marco de una política integral que entienda a las personas como sujetos de derechos y participantes activos en sus comunidades, que apunten a la inclusión social, el fortalecimiento de las redes sociales y la mejora de la calidad de vida.

En este sentido, el Programa Nacional tiene como propósito promover líneas de acción para el abordaje integral de la problemática de suicidio y ser un núcleo articulador del trabajo con otros actores en los distintos niveles, interministerial e interjurisdiccional. La creación de este Programa Nacional se da en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación y permite fortalecer el trabajo tendiente a reducir los procesos suicidas. Pretende, a su vez, fortalecer las políticas y programas jurisdiccionales, y las acciones que se vienen desarrollando en los distintos efectores locales, trabajando en forma mancomunada tanto para potenciar los recursos existentes como para promover la creación de otros nuevos.

La propuesta de este programa es el producto de una revisión y síntesis de la bibliografía tanto nacional como internacional en materia de abordaje de la problemática del suicidio. Se tomaron como referencia los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre los programas de prevención del suicidio y otros que han resultado de eficacia en sus respectivos países de aplicación.

RESPONSABLES.

La Unidad Ejecutora del Programa

Se prevé que la implementación del Programa esté bajo dependencia directa de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Sin embargo, atento a la complejidad de la problemática y desde una perspectiva integral en salud, es necesario una planificación de líneas de trabajo en forma conjunta con otras dependencias tanto del Ministerio de Salud de la Nación como con otras reparticiones del Estado nacional para el desarrollo de una política pública en la materia.

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones tendrá como objetivo garantizar que las medidas y acciones incluidas en este Programa sean efectivamente implementadas conforme a criterios unificados. El programa estará integrado por un equipo técnico especializado e interdisciplinario.

Las funciones de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones en tanto Unidad Ejecutora del Programa serán:

a) Garantizar la implementación y el seguimiento de las medidas del Programa;

- b) Promover la articulación eficiente entre el Ministerio de Salud y otros ministerios intervinientes;
- c) Garantizar la gestión integrada y coordinada de la información epidemiológica en materia de autolesiones y suicidios;
- d) Monitorear el avance de la implementación del Programa, evaluando el alcance y eficacia de sus acciones.

El programa a su vez, se desarrollará en dos grandes niveles de acción:

La gestión interministerial del programa:

Coordinación general del Programa (coordinación técnica, operativa y administrativa), seguimiento de implementación y monitoreo de resultados. Articulación con la Mesa Interministerial para el abordaje socio-comunitario de la problemática del suicidio en población general con foco en adolescencias y juventudes (MinterSui).

La gestión federal del programa:

Articulación federal con instancias de gestión a nivel provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. MARCO NORMATIVO.

- Ley Nacional N° 26.657 – Derecho a la Protección de la Salud Mental. Decreto Reglamentario N° 603/2013.
- Decreto 426/2021 – Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones.
- Ley Nacional N° 27.130 - De Prevención del Suicidio y DR N° 603/2021.

En 2015 por unanimidad en ambas Cámaras se sancionó en nuestro país la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130. El objetivo de la norma es “la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y postvención”. La Ley declara “de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio”. Y entiende al intento de suicidio “a toda acción autoinfligida con el objeto de generarse un daño potencialmente letal”. En lo que refiere a asistencia, la Ley Nacional indica que quien padeció ideaciones y/o conductas suicidas “tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud”.

En el año 2020, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, se elaboró el Proyecto de Decreto con la Reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130. En el texto del Proyecto de Decreto de Reglamentación se incorporaron los aportes de las autoridades de Salud Mental y Adicciones de las distintas jurisdicciones del país; del Órgano de Revisión Nacional de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657; del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones; de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); de UNICEF y de la Mesa de Trabajo Intersectorial para el Abordaje Socio-comunitario de la Problemática del Suicidio en Población General con Foco en Adolescencias y Juventudes. La reglamentación de esta ley promueve la unificación de registros sobre suicidios e intentos de suicidios y procura habilitar líneas telefónicas gratuitas de escucha a situaciones críticas. Además, insta a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga a dar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias. Se trata de una ley que deja en claro la necesidad de solicitar medidas de protección integral de niños, niñas o adolescentes en los casos en que un niño, niña o adolescente intenta suicidarse y pugna, entre otras cosas, por generar espacios de trabajo sistemático con referentes de los medios de comunicación de alcance nacional y provincial, entendiendo que la OMS destaca entre los métodos de prevención a la información responsable por parte de los medios de comunicación.

Otras Leyes Nacionales (por orden cronológico):

- Ley Nacional N° 23.054 – Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
- Ley Nacional N° 23.849 – Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley Nacional N° 25.421 – Programa de Asistencia Primaria de la Salud Mental.
- Ley Nacional N° 26.061 - Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Decreto Reglamentario N° 415/06.
- Ley Nacional N° 26.522 – Servicios de Comunicación Audiovisual. Decreto Reglamentario 1.225/2010.
- Ley Nacional N° 26.529 - Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Decreto Reglamentario N° 1.089/2012
- Ley Nacional N° 26.743 – De identidad de Género.
- Ley Nacional N° 26.934 –Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos.
- Ley Nacional N° 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación.
- Ley Nacional N° 27.360 – Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.

Decretos, resoluciones complementarias y recomendaciones (por orden cronológico):

- Decreto N° 457/2010 - Creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
- Resolución N° 506/2013 del Ministerio de Seguridad – Aprobación Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad.
- Resolución N° 1876 - E/2016 – Aprobación Normas para Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones sin Internación.
- Recomendación de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones del año 2014 - Recomendaciones a los Servicios Asistenciales para la Revisión de las Declaraciones Judiciales de Incapacidad e Inhabilitación.

3. ANÁLISIS SITUACIONAL.

Según el último informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en junio de 2021, más de 700.000 personas se suicidan cada año en el mundo. Los datos relevados indican que una de cada 100 muertes es por suicidio y que este hecho se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. Además, se calcula que por cada muerte autoinflingida se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio, que se traducen en lesiones y/o hospitalizaciones además de impactar en la Salud Mental de la persona y su entorno. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante.

El suicidio, además, es la cuarta causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, por detrás de los traumatismos por accidentes de tránsito, la tuberculosis y la violencia interpersonal.

Conforme los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se hace necesario impulsar medidas para cumplir la meta de reducir un tercio la tasa de suicidio a nivel mundial.

Según la información de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación, durante el período 2010-2019 se produjeron en nuestro país, 31.847 muertes por suicidios. Además, si se toman en cuenta los datos publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) para el año 2019, basados en un Sistema de Alerta Temprana que relevan los suicidios consumados (en tanto se trata de un tipo de muerte violenta que implica la intervención de las fuerzas de seguridad), la tasa de suicidios para el año 2019 fue de 8,7 por cada 100.000 habitantes, superior a la que puede construirse con las cifras de mortalidad publicadas por la Dirección de Estadísticas en Salud del Ministerio de Salud, que fue, según datos provisorios, de 7,3 por cada 100.000 habitantes para ese mismo año.

En cifras absolutas, de 3.569 casos relevados por el SNIC, 971 corresponden a adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años, es decir el 27,1%. Siendo 225 mujeres y 746 varones. Los suicidios siguen siendo mayores en varones que en mujeres (mueren 3 varones por cada mujer en estos grupos de edades).

En este sentido, también es relevante destacar que si se analizan las prestaciones del Programa SUMAR, desde julio de 2019 a marzo de 2021, las correspondientes a suicidio o intentos de suicidio aparecen entre las 5 primeras prestaciones en 11 provincias del territorio nacional: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En nuestro país, las tendencias y distribuciones por sexo y mecanismos elegidos para la ejecución del suicidio, son similares a lo observado en la región y a nivel mundial. Se observa mayor predominio de varones y principalmente el uso de ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación como mecanismo de consumación. El grupo de edad en el que se pierden más años es el de 20 a 24 años. Desde la declaración de la pandemia en marzo de 2020, la OMS viene advirtiendo respecto de los efectos que se están evidenciando en la salud mental de las personas como consecuencia de la misma. Estas advertencias incluyen también la proyección de los efectos mencionados en el largo plazo, entre los cuales se puede inferir un aumento de los padecimientos psicosociales en general, y de los casos de suicidio, en particular. Por ello, la respuesta sanitaria en términos de salud mental es considerada una prioridad que los Estados deben asumir.

4. EJES Y OBJETIVOS DE TRABAJO.

Este Programa tiene el propósito de fortalecer el abordaje integral de la problemática del suicidio a través de la implementación de estrategias intersectoriales de prevención, asistencia y post-vención.

Eje 1: RECTORÍA.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y jurisdiccionales para que los distintos actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales, implementen políticas que garanticen calidad, accesibilidad y equidad en el abordaje de la problemática del suicidio.

Objetivos:

- 1.1 Promover la adecuación de los marcos normativos jurisdiccionales al marco normativo nacional vigente.
- 1.2 Fortalecer el carácter federal de las políticas públicas de abordaje integral de la problemática del suicidio.
- 1.3 Fomentar la cooperación internacional en las políticas públicas nacionales de abordaje integral del suicidio.
- 1.4 Fortalecer las herramientas técnicas para el abordaje integral de la problemática del suicidio.

Eje 2: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN.

Fortalecimiento de los lazos sociales, a través de intervenciones oportunas con enfoque territorial y perspectiva de derechos.

Objetivos:

2.1 Desarrollar acciones y estrategias de sensibilización para población general.

2.2 Fortalecer el adecuado abordaje comunicacional de la problemática del suicidio

2.3 Promover estrategias intersectoriales de abordaje integral de la problemática del suicidio a nivel local

Eje 3: ATENCIÓN Y POSTVENCIÓN.

Atención adecuada de las personas con autolesiones e intento de suicidio y la postvención en las situaciones de suicidio consumado en la red local de servicios de salud, en el marco del respeto y del cumplimiento de los derechos de las personas.

Objetivos:

3.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de las redes locales sanitarias y de apoyo psicosocial.

3.2 Promover la ampliación del acceso a la cobertura prestacional en Salud Mental de personas con intento de suicidio y sus referentes afectivos.

3.3 Promover la creación y/o fortalecimiento de líneas telefónicas jurisdiccionales gratuitas para la atención de situaciones críticas.

Eje 4: FORTALECIMIENTO DEL RRHH EN SALUD/SALUD MENTAL.

Desarrollo de acciones formativas dirigidas a profesionales sanitarios en general y de la Salud Mental en particular, a actores de ámbitos educativos, laborales, recreativos, contextos de encierro, así como a distintos agentes que realizan intervenciones psico-sociales en lo que respecta a procesos de prevención y abordaje de la conducta suicida en la población.

Objetivos:

4.1 Implementar estrategias de capacitación sobre el abordaje integral del suicidio de los equipos de salud de los diversos niveles de atención.

4.2 Fomentar programas de capacitación en ámbitos educativos, laborales, recreativos, contextos de encierro, entre otros.

4.3 Promover la capacitación de fuerzas de seguridad para actuación ante urgencias en domicilio y vía pública.

Eje 5: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Desarrollo y fortalecimiento de sistemas de información de calidad, relevante y oportuna que contengan las variables específicas del suicidio y la conducta suicida en tanto insumo para la planificación y evaluación de las políticas públicas de abordaje de la problemática.

Objetivos:

5.1 Fortalecer el acceso y la disponibilidad de información epidemiológica para la planificación y evaluación de políticas públicas

5.2 Implementar un sistema de notificación sanitaria obligatoria de los intentos de suicidio.

5.3 Llevar adelante la recopilación y análisis constante de datos específicos para utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica del Programa.

5.4 Implementar estrategias de vigilancia epidemiológica con base territorial en todo el territorio nacional.

5. ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA POR CURSO DE VIDA.

En relación a los grupos poblacionales más relevantes en términos epidemiológicos, se observa en la República Argentina una distribución similar a la observada en América del Sur. Así, en cuanto a los grupos etarios las tasas más elevadas son personas adultas -45 a 59 años-, personas mayores -más de 70 años-, seguido de los jóvenes -20 a 24 años- (OPS, 2014).

Infancia y adolescencia.

Tanto la infancia como la adolescencia son períodos de crecimiento y desarrollo humano fundamentales para la constitución como personas y sujetos sociales. En particular, la adolescencia es una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, donde se vivencia un proceso acelerado de cambios tanto a nivel físico como psíquico.

Los distintos organismos internacionales alertan sobre el crecimiento de las tasas de suicidio en población adolescente en los últimos diez años y la necesidad de promover políticas públicas destinadas a su prevención (UNICEF 2019, OMS 2021).

La promoción de factores protectores es fundamental para el trabajo con esta población, entre los que se puede visualizar el desarrollo de habilidades socio-emocionales, el fortalecimiento de las redes sociales de soporte de las personas, la inclusión y participación en actividades en distintos ámbitos de la comunidad. A su vez, es importante trabajar con los distintos actores de la comunidad para la detección y atención temprana de posibles comportamientos con riesgo suicida. Es preciso tener en cuenta que existen situaciones que acrecientan el posible riesgo tales como las situaciones de violencia y abuso sexual, la escasa comunicación o aislamiento, entre otros.

Personas mayores.

Las personas mayores de 60 años tienen un especial riesgo asociado al suicidio que aumenta conforme va aumentando la edad (OMS). Las tasas de suicidios de hombres de edad superior a 79 años tiene una especial consideración ya que aumentan considerablemente llegando a cifras que pueden triplicar las tasas totales (OMS 2020).

Entre las variables intervinientes que se asocian al suicidio en las personas mayores están vinculadas al padecimiento de enfermedades crónicas o terminales, a la discapacidad, hospitalizaciones prolongadas, deterioro cognitivo y demencia, así como a la soledad, la inactividad, la ausencia de proyectos vitales y la carencia de relaciones sociales.

8. BIBLIOGRAFÍA.

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) (2017). Plan Nacional de Acción para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2020. Disponible en <http://bit.ly/PNAPNNyA2016-2020>

Diana Altavilla (2013). Reconstrucción(es) luego de un suicidio: afectación en la familia y el entorno social. Salud Mental y Malestar Subjetivo. Debates en Latinoamérica.

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2017). Políticas de Cuidado en la Escuela. Aportes para trabajar la Problemática de Suicidio.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2017). Comunicación, Infancia y Adolescencia: Guías para periodistas.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2019). El Suicidio en la Adolescencia. Situación en la Argentina.

Ley 26.061. Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sancionada: septiembre 28 de 2005. Promulgada: octubre 21 de 2005

Ley 26.657. Ley Nacional de Salud Mental Decreto Reglamentario 603/2013. Sancionada: Noviembre 25 de 2010. Promulgada: Diciembre 2 de 2010

Ley 27.130 Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Sancionada: Marzo 11 de 2015 Promulgada: Abril 6 de 2015.

Ministerio de Educación de la Nación (2017). Acerca de la Problemática del Suicidio en Adolescentes y Jóvenes. Un enfoque para su abordaje desde el campo de la Educación. Disponible en <https://www.educ.ar/recursos/127063/acerca-de-la-problematika-del-suicidio-de-adolescentes-y-jov/download/inline>

Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia PNSIA (2017). Abordaje de la morbilidad adolescente por causas externas (MMACE). Disponible en <https://bancos.salud.gob.ar/recurso/abordaje-de-la-morbimortalidad-adolescente-por-causas-externas-mmace>

Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información en Salud y UNICEF (2019). Estadísticas de los hechos vitales de la población adolescente en la Argentina. Disponible en <http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/07/Poblacion-adolescente-2.pdf>

Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (2014). Sobre la Problemática del Suicidio en Adultos Mayores. Módulo sobre el Abordaje de la Problemáticas del Suicidio en el Primer Nivel de Atención para equipos territoriales de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (2013). Comunicación Responsable: Recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios. Disponible en https://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000799cnt-2018_recomendaciones-tratamiento-salud-mental-en-los-medios.pdf

Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (2013). Lineamientos para la atención de la Urgencia en Salud Mental. Disponible en https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-08/2020-atencion-de-las-urgencias-en-la-salud-mental_0.pdf

Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (2012). Lineamientos para la Atención del Intento de Suicidio en Adolescentes. Disponible en <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-08/2020-lineamientos-atencion-intento-suicidio-adolescentes.pdf>

Organización Panamericana de la Salud (OMS) (2014). Prevención del suicidio: un imperativo global.

Organización Panamericana de la Salud (OMS) (2016). Prevención de la conducta suicida.

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2017). Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017). Prevención del suicidio: un recurso para los profesionales de los medios de comunicación.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021). Guía de Servicios de Salud Mental Comunitaria (Guidance on community health mental services).